



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 14:51:05

Página 1 de 6

Información Paciente

Nombre : Tania Andrea Silva Espinoza	Rut : 13.628.554-8	N° Archivo : 0105847	N° Epicrisis
Edad : 44a 10m 29d	Fecha Nacto : 14/09/1979	Sexo : Femenino	404529
Dirección : Bahía Navidad 1740	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 7341 1689	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso : 09/05/2024	00:46	Días Estadía : 95
Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso	Fecha Egreso : 12/08/2024	13:08	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Atención De Traqueostomía

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS SALA BÁSICA
05/08/2024

Nombre: Tania Silva Espinoza
RUT: 13628554-8
Edad: 44 años
FI CASR: 08/05/2024
FI UPC: 09/05/2024
FI PAM: 17/06/2024
FI SALA: 26/06/2024
FRI UTIM: 10/07/2024
FRI Sala: 22/07/2024

ANTECEDENTES
Mórbidos: Obesidad mórbida, Sífilis primaria tratada (2020), DM2 NIR, Trastorno de la personalidad límite, Trastorno afectivo bipolar tipo I.
Medicamentos: Flufenazina, Clonazepam, Losartan, Litio, Olanzapina, Atorvastatina, Aripiprazol, Pregabalina, Topiramato, Metformina y Glibencamida.
Quirúrgicos: Histerectomía en contexto de absceso tubo ovárico (2017)
Alergias: Amoxicilina
Hospitalizaciones recientes: 2017 por absceso tubo ovárico.
Hábitos: TBQ 1 cajetilla al día. Alcohol: ocasional. Drogas: policonsumo suspendido hace 4 años (principalmente pasta base de cocaína).
Inmunizaciones: Covid-19 2 dosis, Influenza NO
Social: Tiene 2 hijas de 26 y 14 años, vive junto a la menor y a su madre. Contacto familiar +56995886018. Trabajó como maestra de cocina hasta hace 14 años atrás. Cuenta con pensión de invalidez.

MOTIVO DE CONSULTA: Insuficiencia respiratoria y síntomas catarrales.

ANAMNESIS
Fecha Epicrisis : 12/08/2024 14:51

Página 1 de 6

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 14:51:05

Página 2 de 6

Paciente con antecedentes descritos consulta por cuadro de aproximadamente 1 semana de evolución de síntomas catarrales, que 3 días previos al ingreso evoluciona con sensación febril no cuantificada y disnea progresiva que llega hasta ser de mínimos esfuerzos. Consulta por persistencia de síntomas.

Ingresa en regulares condiciones generales, PA 71/52, FC 95, FR 32, Sat 95% FiO2 15 Lts por Mascarilla de no recirculación.

Al examen físico destaca la presencia de sibilancias difusas bilaterales.

Se evaluó con laboratorio inicial donde destaca: Glicemia 501, Glóbulos blancos 10770, PCR 180, pH 7.17, CO2 59, O2 37.3, lactato 20.

Evoluciona con empeoramiento de su condición debiendo conectarse a VMNI en UEA. Posteriormente evoluciona con mala mecánica respiratoria pese a VMNI requiriendo conexión a VMI mediante IOT (Se instala tubo 8 en primer intento sin incidentes).

AngioTAC de tórax que descarta TEP, pero evidencia signos de neumopatía multifocal bilateral concordante con antecedente de influenza, junto a signos de DHC incipientes.

Posterior a eso se mantiene en REA con empeoramiento clínico progresivo, evolucionando con aumento persistente de CO2, pese a Ventilación mecánica, y PaFi progresivamente en disminución a pesar de estar con FiO2 al 100%. Sumado a esto, presenta inestabilidad hemodinámica con requerimientos de DVA (Noradrenalina) hasta dosis moderadas. Se presenta a UPC para manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) severo

PaFi de ingreso: 76

2. Shock séptico de foco pulmonar

NAC multilobar por Influenza tipo A

Sospecha de sobreinfección bacteriana

3. Crisis hiperglicémica grave no CAD/SHH.

4. Antecedentes: Obesidad mórbida, Sífilis primaria tratada (2020), DM2 NIR, Trastorno de la personalidad limite.

EVOLUCIÓN POR PLANES Y PROBLEMAS

- Hemodinamia: Ingresa con shock séptico de foco pulmonar, asociado a inestabilidad hemodinámica con requerimientos de DVA (norepinefrina y vasopresina) transitorio hasta el 29/05 tras lograr autosostenerse HDN. Posteriormente con terapia antihipertensiva (Amlodipino, Hidralazina e Isosorbide), que se titula a la baja por buen control PA. Al alta quedó pendiente el ecocardiograma transesofágico para estudio de obs CIA.

- Respiratorio: Ingresa con SDRA severo caracterizado por PaFi 100 y retención de PCO2, manejado inicialmente con VMNI, con requerimientos de IOT-VMI. Dado deterioro progresivo de PaFi, se intentan maniobras de reclutamiento, con parcial respuesta, por consiguiente se inicia manejo con Bloqueadores neuromusculares (09/05) y posteriormente protocolo de prono (10/05). Patrón obstructivo severo manejado con broncodilatación y corticoides sistémicos, además BIC de Ketamina (23/05) y epinefrina (suspendida 16/05). Completa 4 días en prono y se supina el 15/05. Destete de BNP exitoso el 20/05. Control con TAC del 19/05 descarta TEP pero persistencia atelectasias basales con resolución de opacidades de Lóbulos superiores. Logra extubación el 04/06 en plan de consolidar weaning, no obstante el 06/06 recae nuevamente febril y con deterioro de drive ventilatorio, realizando secuencia de intubación rápida e IOT con conexión a VMI. Dado VMI prolongada y alta posibilidad de miopatía, se realiza TQT el 10/06. Mantiene rehabilitación con kinesioterapia respiratoria hasta el alta. Sin requerimientos de O2.

- Infeccioso: Presentó las siguientes interurrencias: Infección por influenza A: Se indicó oseltamivir que completa con 5 días. Sobreinfección bacteriana pulmonar inicial: Se identifica en CAET un Haemophilus influenzae y una E. Coli multisensible, por lo que se prescribe Ceftriaxona durante 10 días y Azitromicina por 5 días.

24/05 elevación de Parámetros inflamatorios y fiebre, por lo tanto se realiza pancultivo y rotación de invasivos con inicio de terapia de Imipenem y vancomicina. En cultivos se identifican Candida albicans en orina tratada con Fluconazol por 7 días, además SAMR y Morganella Morganii R en CAET por lo que se ajusta manejo ATB el 28/05 a Vancomicina y Tazonam completando 10 días

El 02/06 desarrolla nuevo hit febril, decidiéndose pancultivar y escalar nuevamente de Tazonam a Imipenem (manteniendo Vancomicina). 07/06 CAET con desarrollo de Morganella Morganii BLEE y KPN ambas MS. Impresiona sólo traqueítis por estos agentes. Queda con meropenem y se suspende vancomicina, pero tras resultados de susceptibilidad se ajusta manejo a Ciprofloxacino en plan de completar 7 días.

Fecha Epicrisis : 12/08/2024 14:51

Página 2 de 6

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 14:51:05

Página 3 de 6

Suspende imipenem + vancomicina, queda con amikacina y completa 7 días. Actualmente sin CUP al alta. Presenta episodios de diarrea autolimitado, PCR CD negativo (09/08)

- Renal / medio interno: Requerimiento de Terapia de reemplazo renal (TRR) al ingreso. Recibió HFVVC con EMIC2 el 13/05 y el 14/05 con HD convencional. Dado estabilidad de medio interno se retira catéter de hemodiálisis el 23/05. Cursa con Hipernatremia secundario a poliuria. En UTIM cursa AKI KDIGO II, culpándosele a sobredepleción y niveles plasmáticos supratérmicos de Litio. Se maneja bien con volemicación sin requerimientos de pasar a diálisis de agudo. Se suspenden momentáneamente otros fármacos nefrotóxicos, pero se reinician previo al traslado. Se va de alta con Crea de 0.57 (08/08)

Metabólico: Ingresa con hiperglucemia sin criterios de Cetoacidosis diabética, evoluciona posteriormente con profundización de cuadro clínico. Mantuvo BIC de insulina por aproximadamente una semana, más volemicación y seguimiento gasométrico, logrando finalmente el 18/05 traslape a Insulina NPH. Nueva interurrencia séptica (24/05) con BIC, suspendida el 30/05 retomando esquema basal. Ya en sala, con requerimientos bajos de insulina NPH, por lo que se inicia metformina, con buena respuesta y tolerancia. Al alta se suspende NPH y queda con 2 comprimido de metformina de 850 mg al día.

- Endocrinológico: En primera estadía de sala, específicamente el 26/06, desarrolla hipercalcemia leve PTH independiente, la cual se atribuye a su inmovilización prolongada. Sin embargo, posteriormente desarrolla niveles severos de hipercalcemia en UTIM (10/07), asociado a falla renal. Se atribuye a dosis tóxica de Litio, que superó los niveles plasmáticos al control de laboratorio, por lo que se suspende Litio e inicia volemicación agresiva, resolviendo apropiadamente sin necesidad de mayor terapia. Normaliza calcio pero luego evoluciona con hipercalcemia levemente elevada (peri 11.5) con PTH baja e hiperfosfemia peri 5.5. Discutido con endocrinología, se plantea hipercalcemia por inmovilización prolongada por hospitalización, pero debe hacerse seguimiento (si persistiera descartar neoplasia, aunque cuenta con TAC TAP sin imágenes sugerentes de neoplasia. Se va de alta con Calcio de 10.7 (08/08)

Nutricional: Durante la hospitalización desarrolla desnutrición grave por criterios GLIM (pérdida de peso de 12 kg hasta 103 kg). Por lo tanto, se mantiene con régimen enteral con Diben, en terapia fondoaudiológica, autorizándose retiro de sonda el 06-08. Al alta debe recibir dieta especial de régimen semi sólidos y líquidos con espesantes con UHD para lo cual nutrición de piso y ANI entregan pauta alimentaria con régimen de papillas, visitas de nutricionista domiciliaria y control semanal de parámetros nutricionales.

Psiquiátrico: Antecedentes de TAB-I y trastorno de personalidad límite, con gran cantidad de psicofármacos. Equipo de psiquiatría ajusta psicofármacos. Litio suspendido por hipercalcemia secundaria a toxicidad farmacológica. Evoluciona bradipsíquica y disfórica, con requerimientos constantes de opiáceos (Metadona) horarios y de rescate, por lo que es evaluada por Psiquiatría, no impresionando dependencia a opiodes y modifican dosis de analgesia. Evaluada por fisiatría, agregan Tapentadol y Duloxetina, aumentan Pregabalina y proponen decalaje progresivo de Metadona. Previo al alta se solicita conciliación de fármacos a psiquiatría, con quienes se acuerda suspender Duloxetina por RAM en Tr. bipolar, además de mantener el resto de fármacos.

Rehabilitación:

-FNA: Se indica régimen 0 oral y uso de sonda nasogástrica dado vía aérea manejada con traqueostomía. Énfasis en rehabilitación con válvula de oclusión a tolerancia, pero se sugiere que en caso de fatiga (respiratoria o deglutoria), se pase a fonación. Se mantiene durante hospitalización con SNG debido a trastorno deglutorio severo confirmado con Nasofibroscoopia por Otorrinolaringología en conjunto con Fonoaudiología, el cual le provoca aspiración silente de líquidos claros. Progresa a alimentación complementaria con papillas/comotas, mas no se permitió ingesta de agua VO. Fonoaudiología autoriza alta con UHD, sin SNG y régimen en base a papillas VO.

KNT: Se recibe a paciente imposibilitada de caminar y mantener sedestación por cuenta propia. Con trabajo de kinesiología se avanza paulatinamente a mayor tolerancia de sedestación y deambulación con asistencia técnica de andador + personal. Aquello mejora parcialmente el dolor de miopatía del paciente crítico, pero le provoca dolores musculares en EEII, atribuidos a ejercicio post reposo prolongado.

Profilaxis: Se mantiene con tromboprofilaxis con HBPM (enoxaparina) e IBP (omeprazol) en contexto de hospitalización y uso de SNG, respectivamente.

Social: Se entregan recetas para tramitación de baño portátil en conjunto con asistente social.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

Fecha Epicrisis : 12/08/2024 14:51

Página 3 de 6

Paciente crítica crónica en rehabilitación:

Miopatía del paciente crítico.

Neuropatía del paciente crítico

AKI KDIGO 2, obs. Prerenal, resuelta

Quemadura grado II de zona anterior de la pierna izquierda.

ITS CVC (PICC) por KPN MS

Hipercalcemia PTH independiente (inicialmente severa, luego leve)

Obs. por Litio +/- Reposo prolongado

Antecedentes

RESUELTOS

SDRA severo

VMI 09/05- 10/06

TQT decanulada 19/07

AKI con necesidad de TRR, recuperada

Múltiples interurrencias infecciosas:

Neumonía multifocal por Influenza A, H. influenzae y E. coli MS

ITU x Cándida Albicans.

NAVM por SAMS y Morganella Morganii.

Traqueitis por KPN MS y Morganella Morganii.

ITU por Klebsiella BLEE

ÚLTIMOS EXÁMENES EN SALA BÁSICA DE MEDICINA

Laboratorio

06/08 Prealbúmina rechazada, albúmina 3.2, Ca 10.7, Crea 0.57, BUN 17.2 Fósforo 4.9 PCR 19.5 ELP 140/3.76/107

05/08 Hb 10.0 VCM 98.4 CHCM 31.5 GB 6.86 Plaquetas 307000. ELP 140/ 3.58/ 105. GSV pH 7.32 PCO2 45.5 PO2 42.4 HCO3 23.4 BE -2.6. Albúmina 3.1 Ca 10.2 Fósforo 5.4 Mg 1.7

31/7 Albúmina 3.1 Ca 11.2 Fósforo 5.6 Mg 2.0 Niveles Vitamina D 23.0 PTH 7.0 ELP 139/ 3.96/ 105

30/7 Hb 10.2 VCM 97.8 CHCM 30.6 GB 6.140 Plaquetas 358000 ELP 139/ 4.02/ 104 Ca iónico 6.2 Albúmina 3.2 Calcio 11.4 Fósforo 5.1 Mg 2.0 Hb1Ac 5.8

29/7: Albúmina 3.2 FA 159 Ca 11.6 Crea 0.67 BUN 26.4 Fósforo 4.6 LDH 109 Mg 1.9 Hb 10.5 VCM 98. CHCM 31.9 GB 6.170 Plaquetas 335000 ELP 139/ 3.82/ 103. GSV pH 7.30 PCO2 58.6 HCO3 28.4 BE 2 SAO2 39.9%

27/7: Hb 11.6 VCM 96.6 CHCM 32.1 GB 8.250 Plaquetas 374000

Imágenes y otros

31/7 Nasofibroscopia: FND: permeable, mucosa sana. SNG in situ.

R in of aringe: Torus y fositas libres.

Orofaringe: Base de lengua sin alteraciones.

Hipofaringe: Vallécula y senos piriformes con escasas secreciones aposadas tipo saliva.

Laringe: Anatomía globalmente conservada. Movilidad cordal conservada en abducción y aducción, sin lesiones de borde libre.

Subglotis difícil de evaluar, impresiona libre. Sensibilidad disminuida a derecha, conservada a izquierda.

Semisólidos 5-5-5 ml: retiene en senos piriformes y vallécula que limpia frente a degluciones repetidas con algo de dificultad.

En las 3 pruebas con 5 ml penetra al vestíbulo, sin embargo sin evidencia de aspiración clara.

Líquidos claros 3 ml: Penetra y aspira de forma activa, sin reflejo de tos.

Galleta: Penetración en vestíbulo laríngeo.

Dg. ORL

Trastorno de deglución severo.

CONDICIÓN DE ALTA

Paciente en buenas condiciones generales, normotensa, normocárdica, eupneica con apoyo intermitente de O2 por naricera FIO2 2 litros, buena mecánica ventilatoria, afebril. Se encuentra actualmente con dolor en extremidades inferiores EVA 5/10 de carácter urente, el cual ha ido reduciendo durante la hospitalización. Diuresis espontánea, clara, con deposiciones espontáneas y sin hallazgos patológicos, ambos intermitentemente en ¿chata¿ y pañales. Con ingesta oral reducida a semi sólidos debido a trastorno de deglución severo en rehabilitación. Deambulando con asistencia técnica de andador. Por lo anterior, se envía de

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 14:51:05

Página 5 de 6

alta con unidad de hospitalización domiciliaria para continuar con rehabilitación motora, fonoaudiológica y de terapia ocupacional.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

CONDICIÓN DE ALTA

Paciente en buenas condiciones generales, normotensa, normocárdica, eupneica, sin requerimientos de oxígeno, buena mecánica ventilatoria, afebril. Se encuentra actualmente con dolor en extremidades inferiores EVA 5/10 de carácter urente, el cual ha ido reduciendo durante la hospitalización. Diuresis espontánea, clara, con deposiciones espontáneas y sin hallazgos patológicos, ambos intermitentemente en chata y pañales. Con ingesta oral reducida a semi sólidos debido a trastorno de deglución severo en rehabilitación. Deambulando con asistencia técnica de andador. Por lo anterior, se envía de alta con unidad de hospitalización domiciliaria para continuar con rehabilitación motora, fonoaudiológica, de terapia ocupacional y nutricionista.

Plan Post Alta

Alta con hospitalización domiciliaria para: kinesioterapia motora, fonoaudiología y seguimiento nutricional.

Medicamentos

Paracetamol 500 mg. 2 comprimidos c/8 horas vía oral molido con espesante
Metamizol 300mg. 1 comprimido c/8 horas vía oral molido con espesante hasta control con fisiatría
Bromuro de Ipratropio 2 puff cada 8 horas por aerocámara
Pregabalina 300 mg. 1 comprimido cada 12 horas por vía oral molido con espesante
Metadona 2 mg c/24 hrs SC hasta control con fisiatría
Quetiapina 100 mg. 1 comprimido en la mañana, uno a medio día y 3 en la noche (cada 8 horas) vía oral molido con espesante
Clonazepam 2 mg. 1 comprimido en la noche por vía oral molido con espesante
Tapentadol 100mg. Medio comprimido cada 12h por vía oral molido con espesante
Omeprazol 20mg al día vía oral molido con espesante
Metformina 850mg 1 comprimido 2 veces al día molido con espesante

controles:

- Medicina física y rehabilitación: control en 10 días manejo del dolor y rehabilitación de miopatía de paciente crítico en CDT
- Medicina interna: Control con medicina interna para control de Hipercalcemia PTH independiente (último Calcio 10.7 del 08/08), supervisar rehabilitación en contexto de paciente de larga hospitalización y verificar adherencia a tratamiento.
- Otorrinolaringología: por trastorno de deglución en 7 días en CDT
- Psiquiatría: seguimiento habitual, retomar controles con Psiquiatría en CRS Cordillera chequear adherencia a psicofármacos, evaluar manejo de comorbilidades de salud mental.
- APS: seguimiento patologías crónicas
- Cirugía: para resolución de colelitiasis en diferido.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Semi Solidos

Medicamentos : Metformina 850 Mg Comp. 2 Comprimidos Cada 12 Horas

Controles

Joel Falcon Acevedo

Bec. Eduardo Galvez Contreras

Ximena Monsalve Valenzuela

Fecha Epicrisis : 12/08/2024 14:51

Página 5 de 6

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 11:37

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 14:51:05

INTERNO

Becado/Residente



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Página 6 de 6

Médico Tratante (Staff)